El Mundo
SALUD · EL MUNDO
MIÉRCOLES, 11 DE NOVIEMBRE DE 2026 · 22:55 H

La lucha de Carmen para salvar a su hija de la enfermedad que mató a su madre y a su abuela: "Esa línea se corta aquí"

Salta a la vista que Candela ha heredado la sonrisa de su madre. Dicen los que las conocen bien que tiene también su manera de mirar. Y que a sus dos meses y medio ya muestra la...

CRISTINA G. LUCIO · **SALUD**

«Mi madre y mi abuela fallecieron por esta enfermedad. Yo he heredado la mutación genética que la provoca. Pero esa línea se corta aquí. Candela no sufrirá el trastorno», dice, emocionada, Carmen Domínguez, la madre de Candela, mientras mira embelesada a su bebé. La pequeña nació libre de la enfermedad gracias a un diagnóstico preimplantacional, una técnica que permite analizar el ADN de los embriones antes de la fecundación en caso de afecciones hereditarias graves. Y su madre no puede estar más feliz de haber tomado esa decisión.

La primera vez que Carmen escuchó esas tres palabras que luego se convertirían en tan habituales -«enfermedad de Huntington»-- tenía 19 años y ninguna idea de lo que significaban. Lamentablemente, enseguida comprendió lo que ese diagnóstico que acababan de darle a su madre iba a suponer.

La enfermedad de Huntington es un trastorno neurodegenerativo que daña progresivamente las células cerebrales. Afecta principalmente a áreas que controlan el movimiento, el comportamiento, la memoria, el pensamiento y las emociones y hoy en día no tiene cura, explica Jesús Pérez, neurólogo del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona y miembro del Grupo de Estudio de Trastornos del Movimiento de la Sociedad Española de Neurología.

«La enfermedad suele manifestarse inicialmente con síntomas neuropsiquiátricos, como irritabilidad, apatía o depresión, que aparecen hasta 10 años antes del comienzo de los síntomas motores y pueden dificultar el diagnóstico». La afección, continúa, provoca un deterioro progresivo, que hace que los pacientes acaben siendo completamente dependientes, con dificultades para deambular, masticar o tragar, así como demencia y alteraciones cognitivas, entre otros problemas incapacitantes que terminan con la muerte del afectado.

«En el caso de mi madre, las primeras alarmas saltaron en el trabajo», recuerda Carmen. «En aquel momento ella tenía 52 años y empezó a tener muchos problemas para concentrarse, para poder realizar sus tareas. Lo que normalmente podía hacer en una hora empezó a costarle más de tres. Y a partir de ahí ya todo fue muy rápido», lamenta. Uno a uno, fueron apareciendo «más problemas cognitivos, obsesiones, cambios en la personalidad y esos movimientos involuntarios que son tan característicos

del trastorno», rememora esta gallega afincada en Cataluña, tres años después del fallecimiento de su madre.

El deterioro progresivo de quienes sufren la enfermedad se debe a una mutación en el gen HTT que provoca que una proteína -denominada huntingtina- vaya acumulándose dentro de las células cerebrales, aclara el neurólogo. Aunque puede aparecer a cualquier edad, la enfermedad suele manifestarse entre los 30 y los 50 años, «un momento en el que las personas se encuentran en la plenitud de la vida, con todos sus proyectos personales, laborales, familiares y vitales en pleno desarrollo», apunta Ruth Blanco, presidenta de la Asociación Española de la Enfermedad de Huntington y de la Federación Española de Asociaciones de Huntington. «Te parte literalmente la vida. La tuya y la de tu alrededor», continúa Blanco, cuyo padre recibió el diagnóstico con apenas 40 años, cuando ella no había cumplido aún los 16.

Según los datos del Ministerio de Sanidad, la prevalencia de la enfermedad es de cinco afectados por cada 100.000 habitantes y aunque las cifras oficiales hablan de unos 2.400 afectados en España y más de 10.000 personas en riesgo de haber heredado la mutación que provoca el trastorno, los afectados y sus familias creen que en realidad son muchos más porque «lamentablemente la enfermedad de Huntington continúa siendo un trastorno en la sombra», denuncia Blanco.

Cada uno de los descendientes de un afectado tiene un 50% de posibilidades de heredar la mutación y desarrollar la enfermedad. Pero, pese a este carácter hereditario, «hasta uno de cada cuatro casos que se diagnostica se produce en familias que nunca antes habían oído hablar de la enfermedad, bien porque no había antecedentes conocidos o porque esos antecedentes estaban ocultos o mal diagnosticados».

Ella misma ha vivido esa experiencia. «Mi padre pensaba que el suyo había muerto de Párkinson. Y conocemos muchos otros ejemplos, con diagnósticos erróneos de Alzhéimer, esquizofrenia, demencia...».

A la familia de Vanesa Rodríguez también le pilló por sorpresa el diagnóstico de su padre, al que le detectaron la enfermedad a los 56 años. «Fue como una bofetada», recuerda esta asturiana. Una bofetada para él y para sus cinco hijos, que se enfrentaron entonces a la incertidumbre de saber si seguirían su mismo destino. «Él vivió muchos años con la enfermedad, con un deterioro tremendo. Al final de sus días teníamos que alimentarle a través de una sonda nasogástrica. Fue muy duro entonces. Y es muy duro ahora, porque dos de mis hermanos tienen confirmada la misma enfermedad», explica.

Hoy en día, el diagnóstico definitivo se produce a través de la prueba genética, un test que también puede llevarse a cabo de forma predictiva, para saber si se está en riesgo de desarrollar la enfermedad. Ese test debe hacerse siempre mediante un proceso de asesoramiento, en el que la persona esté acompañada, valore su motivación para conocer esa información y tenga en cuenta los diferentes escenarios, plantea César Aguilera, neuropsicólogo del Asociación Española de Enfermedad de Huntington. «Hay que valorar si vivir con incertidumbre en ese momento es mejor o peor que enfrentarse a un positivo en el test genético». Parte del acompañamiento previo, continúa el especialista, implica haber pensado «cómo enfrentar, de manera consistente en el tiempo, los dos posibles resultados del test». Carmen, Vanesa y Ruth se han sometido a la prueba. La última lo hizo enseguida, poco tiempo después de conocer la enfermedad de su padre. Sus compañeras lo hicieron años más tarde. Y otras muchas personas, advierten, no llegan a hacerlo nunca.

«En esta enfermedad, muchos prefieren la incertidumbre», comprende Carmen. Ella optó por transitar el proceso del consejo genético hace unos años, cuando ella y su pareja decidieron que querían ser padres. «Yo tenía muy claro que si iba a ser madre quería saber antes cuál era mi situación para, si era positiva, cortar la posibilidad de que mi hija lo heredara», señala.

«Cuando di positivo le pregunté más de 50 veces a mi pareja si estaba seguro de querer estar conmigo. No exagero. Necesitaba que me lo dijese muchas veces, porque ese positivo significaba que pueden venir curvas en algún momento de nuestra vida. Pero él nunca dudó. Y ha sido siempre muy positivo, incluso cuando el primer ciclo de la reproducción asistida salió mal», subraya.

Carmen hace hincapié en que ha trabajado mucho, con la ayuda de un psicólogo, en la gestión de todo el proceso. «Intento mantener la actitud positiva y confiar en la ciencia, pero no siempre ha sido fácil de manejar», reconoce. «Ahora intento centrarme en el presente y pensar que tengo un conocimiento de mi yo del futuro que, cuando llegue, tendré que intentar gestionar de la mejor manera posible».

Carmen conoce que el destino que sufrieron su madre y su abuela está escrito en su genoma, pero no sabe a ciencia cierta cuándo se desencadenará ni cómo será su gravedad, porque hay una gran variabilidad entre los afectados.

Según explica Jesús Pérez, en las personas con enfermedad de Huntington, una parte específica del gen que está alterado contiene tres letras del código genético -CAG- repetidas más veces de lo habitual. Cuanto mayor es el número de repeticiones, más precoz suele ser el inicio y más graves las manifestaciones clínicas. «Tenemos un caso en el que, con 72 repeticiones, la enfermedad ha debutado a los 14 años, pero no es lo habitual», explica el neurólogo.

En el caso de Carmen, su organismo presenta 40 repeticiones, el límite a partir del cual se considera patológico, por lo que se espera que el desarrollo sea más tardío, en torno a los 70 años. «Ahora mismo es algo en lo que intento no pensar mucho. Y es posible que con los avances que está habiendo en investigación y ciencia encuentren algo antes de que aparezca...», desliza.

La investigación sobre la enfermedad de Huntington está viviendo un momento álgido después de años de peregrinación en el desierto, confirma Jesús Pérez. Actualmente hay varios ensayos clínicos en marcha, en los que destacan abordajes de terapia génica dirigidos a bloquear los efectos de la mutación genética que produce la enfermedad. «Algunos de los resultados que estamos viendo, en ensayos en fase II son bastante prometedores», señala Pérez, que se muestra optimista aunque también cauteloso respecto al futuro.

«De momento, yo lo que intento es llevar una vida muy saludable para cuidar todo lo que pueda mis neuronas», apunta Carmen, licenciada en Ciencias de la Actividad Física. Asegura que le encanta nadar, el ejercicio de fuerza y cualquier actividad relacionada con la naturaleza. Y también bailar, una pasión que compartía su madre. «Ella era muy bailonga, disfrutaba mucho con la música. Y a mí me pasa igual. Para mí bailar es una manera de conectar con ella ahora que ya no está», se emociona. «Quizás Candela también saldrá como nosotras. De momento, cuando escucha música no para quieta», pronostica. Y remacha: «En eso de no parar también ha salido a mí. Mi filosofía es intentar aprovechar cada momento y no dejar nada para mañana, porque no sé lo que pasará. Disfrutar el día a día y pensar en el presente. Porque la vida es ahora».

Fuente: https://www.elmundo.es/salud/2026/11/11/6af44516fdddffdf418b457d.html
Recorte generado el 12/11/2026, 6:07:20 · sin publicidad ni recomendaciones.